

Manual da Equipe Multiprofissional na Atenção Primária à Saúde



2023



MISSÃO

“Promover saúde e bem-estar para as pessoas.”



VISÃO

“Ser uma instituição ágil e inovadora, atenta as necessidades de integralidade e sustentabilidade, referência em gestão de saúde pública no Brasil.”

VALORES



Orgulho e Paixão

Transparência

Empatia e Cuidado

Eficiência e Inovação

Sustentabilidade e Governança



SECRETÁRIO DA SAÚDE

Andrei Popovski Kolaceke

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Simone Aparecida de Souza

DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE

Fabiana Fernandes de Almeida

DIRETORIA TÉCNICA

Amanda Bertolo Merki

GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LABORATÓRIO

Louise Domeneghini Chiaradia Delatorre

GERÊNCIA DE DISTRITO SANITÁRIO

Bruna Daniela Dumont Ladeira Landmann – Distrito Centro

Luiza Helena Cardoso dos Santos – Distrito Norte

Jaqueline Fornari – Distrito Sul

GERÊNCIA DE ENFERMAGEM E DE GESTÃO ASSISTENCIAL

Vanessa Cardoso Pacheco

COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE GESTÃO ASSISTENCIAL

Maristela Mello de Aguiar

ELABORAÇÃO

Luci Leia Honorato de Carvalho – Psicóloga, Núcleo de Gestão do Trabalho

Valquíria Aparecida Duarte – Assistente Social, Núcleo de Gestão Assistencial

COLABORAÇÃO

Angélica Schmith – Terapeuta Ocupacional

Claudinéia da Rosa Ferla – Terapeuta Ocupacional

Cristiana Ferreira Freitas da Rosa – Terapeuta Ocupacional

Elise Burmeister – Profissional de Educação Física

Elza Caroline Steffen – Farmacêutica

Flávia Favaretto – Agente Administrativo

Ivete Andrzejewski – Assistente Social

Juliana Prebianca – Psicóloga

Lais Arrivabene Coelho – Profissional de Educação Física

Marcelle Dominoni – Nutricionista

Simone Suzuki Woellner – Fisioterapeuta



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

APS: Atenção Primária à Saúde
AVC: Acidente Vascular Cardíaco
AVD's: Atividades da Vida Diária
AVP's: Atividades de Vida Prática
CIB: Comissão Intergestores Bipartite
DM: Diabetes Mellitus
EM: Equipe Multiprofissional
eSF: Equipe Saúde da Família
ESF: Estratégia Saúde da Família
HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica
IAF: Incentivo para Atividade Física
MS: Ministério da Saúde
NASF: Núcleos de Apoio à Saúde da Família
NAT-Jus: Unidade de Acompanhamento de Processos
PICS: Prática Integrativas e Complementares em Saúde
PTS: Projeto Terapêutico Singular
SEI: Sistema Eletrônico de Informação
SIG-SAÚDETECH: Sistema Integrado de Gestão
SUS: Sistema Único de Saúde
Raps: Rede de Atenção Psicossocial
RDQA: Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	06
2 EQUIPE MULTIROSSIFIONAL EM JOINVILLE	07
2.1 Definição do território a ser coberto pelos profissionais da Equipe Multiprofissional	07
2.1.1 Um a dois profissionais da mesma categoria	07
2.1.2 Três profissionais da mesma categoria	08
2.1.3 Quatro ou mais profissionais da mesma categoria	08
3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	09
3.1 Atividades comuns a todos os profissionais da Equipe Multiprofissional	09
3.2 Atividades específicas por cada profissional na Equipe Multiprofissional	09
3.2.1 Assistente Social	09
3.2.2 Farmacêutico	10
3.2.3 Fisioterapeuta	10
3.2.4 Nutricionista	11
3.2.5 Profissional de Educação Física	11
3.2.6 Psicólogo	12
3.2.7 Terapeuta Ocupacional	13
4 REGISTRO DE PROCEDIMENTOS	14
5 ACESSO A AVALIAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	16
5.1 Matriciamento	16
5.2 Situações Excepcionais	16
6 INSTRUMENTOS DE TRABALHO	18
6.1 Projeto Terapêutico Singular (PTS)	18
6.1.1 Diagnóstico Situacional	18
6.1.2 Definição de Metas	18
6.1.3 Divisão de Responsabilidades	18
6.1.4 Reavaliação	18
6.2 Práticas Integrativas e Complementares em Saúde	18
6.3 Orientação sobre Grupos	19
6.4 Grupos conduzidos pela Equipe Mínima da ESF	19
6.5 Grupos conduzidos pela Equipe Multiprofissional	20
7 ORGANIZAÇÃO DA AGENDA	21
8 INSTRUMENTOS DE APOIO	22
REFERÊNCIAS	23
APÊNDICE A – Fluxograma de acesso à avaliação com a Equipe Multiprofissional	25
APÊNDICE B – Projeto Terapêutico Singular (PTS)	26
APÊNDICE C – Lista de monitoramento de solicitação de Apoio Matricial	28



1 INTRODUÇÃO

A Equipe Multiprofissional é composta por diferentes profissionais da área da saúde que auxiliam na retaguarda especializada às Equipes de Estratégia de Saúde da Família (eSF) da Atenção Primária, por este motivo não possui a premissa de porta de entrada no Sistema de Gestão em Saúde (SIG-Saúdetech), para os usuários.

Dentre os objetivos da Equipe Multiprofissional estão o aumento da resolutividade, racionalização dos serviços, a integralidade do cuidado aos usuários, aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários, contribuindo assim, de forma relevante para a qualidade de vida dos usuários.

O processo de trabalho da EM pode ocorrer por meio de discussão de casos, atendimento individual e/ou compartilhado, interconsulta, construção conjunta de projeto terapêutico singular, educação permanente, intervenções no território de abrangência e na saúde de grupos populacionais de todos os ciclos de vida, da coletividade, ações intersetoriais, ações de prevenção e promoção da saúde.

A EM possui um importante papel de intermediador de acesso às especialidades ou exames, conforme prioridade de cada usuário, respeitando o princípio da equidade e qualificando os encaminhamentos relativos ao seu saber específico.

Conforme Nota Técnica nº 3/2020-DESF/SAPS/MS o Gestor Municipal tem autonomia para compor suas equipes multiprofissionais, deixando de estar vinculada a tipologia Nasf-AB (Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica).

Assim, a Equipe Multiprofissional pode ter diferentes configurações, ou seja, não é necessário que todas as equipes sejam compostas pelas mesmas categorias profissionais.

Desta forma este Manual tem por finalidade descrever as atribuições dos profissionais que pertencem à Equipe Multiprofissional (EM) na Atenção Primária à Saúde (APS).

2 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM JOINVILLE

As equipes multiprofissionais são compostas por diferentes profissionais da área da saúde, atuando de maneira integrada, compartilhando práticas e saberes em saúde, como também, apoiando os profissionais das equipes de Saúde da Família (eSF). A interação entre as EM e eSF propiciará o melhor manejo e/ou resolução de problemas clínicos e sanitários, bem como agregar práticas na Atenção Primária que ampliem o seu escopo de ofertas.

Salientamos que cabe ao Gestor Municipal da Saúde, a definição dos profissionais que irão compor as equipes multiprofissionais, bem como, quantas equipes de Saúde da Família terão como referência, tendo como base os critérios de prioridade identificados a partir das necessidades do território, bem como, da disponibilidade de profissionais em cada especialidade.

A Equipe Multiprofissional pode ser composta pelos seguintes profissionais:

- ✓ Assistente Social;
- ✓ Farmacêutico;
- ✓ Fisioterapia;
- ✓ Nutrição;
- ✓ Profissional de Educação Física;
- ✓ Psicólogo;
- ✓ Terapeuta Ocupacional.

2.1 Definição do território a ser coberto pelos profissionais da Equipe Multiprofissional

A definição do território a ser atendida pela EM, levará em consideração o diagnóstico situacional da Atenção Primária à Saúde (APS), as necessidades de saúde dos usuários, o perfil demográfico da população, os problemas e os riscos coletivos do território, bem como, as principais dificuldades das equipes no cuidado à população.

O diagnóstico situacional será avaliado pelas Coordenações e Gerências da Atenção Primária em conjunto com o Núcleo de Gestão Assistencial considerando os dados registrados no SIG - Saúdetech e o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA).

2.1.1 Um a dois profissionais da mesma categoria

A composição do quadro funcional da EM com um (1) a dois (2) profissionais da mesma categoria será encaminhado para o Distrito Sanitário que apresentar maior necessidade deste profissional, porém estes permanecem como referência para consultorias, quando necessário, dos demais Distritos.

2.1.2 Três profissionais da mesma categoria

A composição do quadro funcional com três (3) profissionais da mesma categoria, estes serão lotados um (1) em cada Distrito Sanitário e serão de referência do seu território de abrangência.

2.1.3 Quatro ou mais profissionais da mesma categoria

Quando da composição com quatro (4) ou mais profissionais da mesma categoria, estes devem ser divididos de forma equilibrada levando em consideração o número de equipes de Saúde da Família em cada território de abrangência.

3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

3.1 Atividades comuns a todos os Profissionais da Equipe Multiprofissional

- ✓ Realizar Matriciamento;
- ✓ Elaborar Projeto Terapêutico Singular (PTS) para situações complexas (Apêndice B);
- ✓ Realizar consulta e atendimento individual específico da sua área de formação;
- ✓ Realizar atendimento compartilhado (com profissionais EM ou eSF);
- ✓ Realizar atividade coletiva específica de sua área de formação ou compartilhada (com profissionais da EM ou eSF);
- ✓ Realizar atendimento domiciliar específico de sua área de formação ou compartilhada (com profissionais da EM ou eSF);
- ✓ Organizar e realizar ações de Educação em Saúde, elaborar materiais de apoio, rotinas, protocolos e outras ações de educação permanente para equipes da sua referência;
- ✓ Promover capacitação técnico-científica, técnico-pedagógica e aprimoramento profissional e interprofissional;
- ✓ Participar de reuniões com profissionais das eSFs, para identificar as reais necessidades da população adstrita;
- ✓ Apoiar e atuar nas ações do Programa Saúde na Escola (PSE).

3.2 Atividades específicas por cada Profissional na Equipe Multiprofissional

3.2.1 Assistente Social

A atuação do Assistente Social está diretamente ligada às questões sociais que os usuários vivenciam nas suas mais variadas expressões quotidianas seja no trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na assistência social pública, etc, (IAMAMOTO, 1997). Essa atuação leva em consideração os princípios da defesa dos Direitos Humanos e Justiça Social, promovendo a autonomia, a participação social, com vistas à superação da desigualdade social, situações de violência, opressão, pobreza, fome, desemprego, etc.

De acordo com o Conselho Federal do Serviço Social na publicação dos parâmetros para a atuação de assistentes sociais na Política de Saúde, dispõe que:

Passa pela compreensão dos determinantes sociais, econômicos e culturais que interferem no processo saúde-doença e na busca de estratégias político-institucionais para o enfrentamento dessas questões. O exercício profissional do assistente social não deve desconsiderar as dimensões subjetivas vividas pelo usuário e nem se reduzir a defesa de uma suposta particularidade entre o trabalho desenvolvido pelos assistentes sociais nas diferentes especialidades da medicina (CFESS, 2010).

O Assistente Social na APS busca a promoção da cidadania e a produção de estratégias para fomentar e fortalecer as redes de atendimentos, propiciando maior integração dos serviços nos territórios adscritos, contribuindo para o desenvolvimento de ações intersetoriais que visem ao fortalecimento da cidadania do usuário.

Prioridades para atendimento na Atenção Primária à Saúde: pessoa com deficiência, criança, adolescente, gestante e idoso que possuam agravos de saúde em situação de negligência com risco de vida, sífilis congênita, desnutrição, pré natal de risco, vulnerabilidade social com agravo em saúde e direito violado em saúde.

3.2.2 Farmacêutico

A atuação dos farmacêuticos visa qualificar o acesso da população à farmacoterapia, contribuir para o uso racional de medicamentos, além de proporcionar cuidado farmacêutico aos usuários e à comunidade (BRASIL, 2018).

A promoção da efetividade e segurança da farmacoterapia é alcançada por meio de ações técnico-gerenciais, técnico-pedagógicas e clínico-assistenciais.

Prioridades para atendimento na Atenção Primária à Saúde:

- ✓ Viabilizar e executar o Cuidado Farmacêutico na Estratégia Saúde da Família (ESF) para usuários crônicos em polifarmacoterapia;
- ✓ Estimular as ações de farmacovigilância junto às equipes e ESF;
- ✓ Usuário que utiliza cinco (5) ou mais medicamentos;
- ✓ Usuário com sessenta e cinco anos de idade (65) ou mais e/ou analfabeto;
- ✓ Usuário que utiliza algum medicamento de alto risco, como anticoagulantes;
- ✓ Usuário que possui duas (2) ou mais doenças crônicas diagnosticadas;
- ✓ Usuário que possui prescrição de dois (2) ou mais medicamentos diferentes no último ano;
- ✓ Usuário que possui dificuldades de organizar, manusear e dúvidas no uso de seus medicamentos;
- ✓ Usuário que foi internado nos últimos seis (6) meses.

3.2.3 Fisioterapeuta

A fisioterapia previne e trata os distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerados por alterações genéticas, por traumas e por doenças adquiridas (Crefito 10).

A atuação do fisioterapeuta na APS é ampla e tem relação tanto com as ações estratégicas em reabilitação, quanto com o direcionamento para a prevenção, promoção e educação em saúde.

Prioridades para atendimento na Atenção Primária à Saúde:

- ✓ Dor crônica (lombar, cervical, fibromialgia, cefaleias, etc), vertigem;

- ✓ Reabilitação da mulher (mastectomia e assoalho pélvico);
- ✓ Polineuropatias (diabética e outras envolvendo dor);
- ✓ Idoso (avaliação física e orientação de mobilidade);
- ✓ Prevenção cardiovascular/AVC em grupos envolvendo diabéticos e hipertensos;
- ✓ Independente de serem de sua área do seu território adstrito: atendimentos de fisioterapia domiciliar conforme Processo SEI 22.0.228273-9.

3.2.4 Nutricionista

O nutricionista deve atuar nos cuidados relativos à alimentação e nutrição voltados à promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico nutricional e tratamento de agravos, como parte do atendimento integral ao indivíduo e à coletividade, utilizando todos os recursos disponíveis ao seu alcance, tendo o alimento e a comensalidade como referência, respeitando a realidade econômica, política, social e cultural, conforme descreve o Artigo 5º do Código de Ética e de Conduta do Nutricionista.

Prioridades para atendimento na Atenção Primária:

- ✓ Crianças/adolescentes baixo peso ou obesidade grave;
- ✓ Usuários acamados;
- ✓ Usuários com obesidade grave;
- ✓ Aleitamento materno e alimentação complementar saudável, em conjunto com as eSF.

Situações Excepcionais

- ✓ Usuários em uso de dieta enteral;
- ✓ Gestante classificada como gestação de médio risco.

3.2.5 Profissional de Educação Física

O profissional de Educação Física desenvolve suas atividades buscando a mudança dos comportamentos sedentários da população, com o intuito de despertar no usuário um estilo de vida mais ativo por meio de exercícios físicos e/ou práticas esportivas duradouras.

A atuação do Profissional de Educação Física interfere diretamente nos dados do Indicador de Incentivo para Atividade Física (IAF) do município, conforme a Portaria GM/MS nº 2.103, de 30 de junho de 2022, que define que, cada Unidade credenciada deve realizar no mínimo 30 (trinta) procedimentos referente à atividade coletiva por mês que contemplem ações de práticas corporais e atividades físicas (Código do Procedimento **0101010036**). Promovendo ações de sensibilização dos demais profissionais para que desenvolvam em suas atividades o referido procedimento.

Prioridades para atendimento na Atenção Primária à Saúde:

- ✓ Usuário com HAS, DM, sobrepeso e obesidade e idosos;
- ✓ Gestantes;
- ✓ Usuário com depressão, ansiedade, insônia;
- ✓ Atendimento voltado para usuário com alta da fisioterapia (principalmente das clínicas conveniadas);
- ✓ Usuário com doenças reumáticas, tais como: osteoartrite, (artrose), fibromialgia, osteoporose, tendinites e bursites, artrite reumatoide e outras patologias que acometem a coluna vertebral.

3.2.6 Psicólogo

O profissional de psicologia tem como premissa de atuação a Resolução do Conselho Federal de Psicologia nº 17 de 19 de julho de 2022, que no seu artigo 5º estabelece que:

A atuação do psicólogo na Atenção Básica deverá estar pautada nos atributos desse nível de Atenção à Saúde, especialmente no que se refere à equidade, à integralidade, à universalidade de acesso, à longitudinalidade, à atenção no primeiro contato e à coordenação do cuidado. Parágrafo único. Serão considerados atributos derivados a orientação familiar e comunitária e a competência cultural.

Prioridades para atendimento na Atenção Primária à Saúde:

- ✓ Usuário com sofrimento psíquico leve a moderado com comprometimento da funcionalidade;
- ✓ Usuário com sintomas psicóticos (leve a moderado).

Situações Excepcionais:

- ✓ Gestantes, puérperas que apresentam sofrimento psíquico;
- ✓ Aborto ou morte de recém-nascido cuja avaliação da eSF identifique sofrimento intenso com necessidade de intervenção;
- ✓ Usuário com psicose (alucinações e delírios): quando não estiver em surto psicótico, se for o caso, seguir Fluxograma da Raps, disponível no Processo SEI 20.0.123311-0 Anexo nº 6977002;
- ✓ Usuário com risco de auto e ou heteroagressão: ideação suicida com suporte familiar, mas sem planejamento ou tentativa prévia; tentativa recente com suporte familiar e adesão ao tratamento na Unidade de Saúde.

Salienta-se que, caso o profissional de psicologia venha a ser desligado do serviço deve programar seu desligamento com antecedência, ou seja, realizar o encerramento dos atendimentos presencialmente com os usuários que estão sob seu cuidado por meio de alta ou transferência de cuidado, conforme preconiza o Código de Ética da categoria.

3.2.7 Terapeuta Ocupacional

O terapeuta ocupacional possui nas suas atribuições profissionais o estudo, à prevenção e o tratamento dos usuários com alterações físicas e psicossociais que interferem no desenvolvimento e na independência em relação às atividades da vida diária (AVD's) e atividades de vida prática (AVP's), trabalho e lazer (Crefito 10).

Em conjunto com o usuário, o terapeuta ocupacional desenvolve o planejamento de vida, considerando o contexto social e de saúde em que o mesmo está inserido, tendo como objetivo a promoção da autonomia e independência.

Prioridades para atendimento na Atenção Primária à Saúde:

- ✓ Avaliar e estimular o desenvolvimento infantil, preferencialmente de crianças na faixa etária de 00 a 03 anos, que apresentam atraso no marco do desenvolvimento neuropsicomotor;
- ✓ Usuários de qualquer faixa etária que apresenta mobilidade reduzida com objetivo de alcançar maior funcionalidade e independência;
- ✓ Usuário com sofrimento psíquico, dificuldade no desempenho das atribuições diárias e com comprometimento na interação social;
- ✓ Usuário idoso que necessite de estímulo cognitivo e mental apresenta limitações na realização de suas atividades práticas da vida diária.

4 REGISTRO DE PROCEDIMENTOS

O registro da produção é fundamental para demonstrar o trabalho realizado, além de ser uma fonte de informação para a realização de diagnóstico, planejamento e avaliação das ações locais de saúde, o que contribui para melhora dos indicadores de saúde e consequentemente captação de recursos financeiros, para tanto é primordial que sejam utilizados os procedimentos corretos conforme Sistema de Informação vigente.

Os Códigos de Procedimentos do Ministério da Saúde estão disponíveis virtualmente no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (<http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp>).

Os Códigos de Procedimentos específicos por categoria podem ser consultados no Memorando SEI: 7593352/2020 e deve ser utilizado o mais específico possível.

Com relação aos Códigos de Procedimentos relacionados às Práticas Integrativas Complementares podem ser consultados no Processo SEI 19.0.130103-3 – Pasta I Anexo II.

O registro eletrônico dos Códigos de Procedimentos das Atividades Coletiva, Grupo Compartilhada e Específica está disponível no Processo SEI 21.0.037534-7, anexo 0012361021.

Cabe à coordenação local monitorar a produção de seus profissionais da EM, assim como ocorre com os demais profissionais das equipes da Estratégia Saúde da Família.

Salienta-se que a Equipe Multiprofissional ao executar algum desses procedimentos deve considerar a realidade de cada território, pois poderá haver mais atendimentos individuais do que grupos, mais visitas do que atendimento compartilhado. Por este motivo, a importância das reuniões de EM e dos matriciamentos para atender sempre que possível a necessidade da população referenciada da melhor maneira.

Sempre que houver dúvida quanto ao registro de produção, o profissional da EM deve contactar a Coordenação local.

Quadro 01 – Descrição dos Procedimentos

Atendimento	Código	Conceito
Atendimento Individual e Específico	Programado Código 0301010030; ou Espontâneo Código 0301040079	O atendimento individual são intervenções específicas de cada categoria profissional com os usuários e/ou famílias, com discussão e pactuação sempre que necessário com os profissionais da eSF responsáveis pelo caso.
Atendimento Domiciliar Compartilhado e Específico	Código 0301010030	Tem como pontos fundamentais o usuário, a família, o cuidador, o contexto domiciliar e a equipe; é uma atividade fundamental para aprofundar o conhecimento a respeito do contexto dos agravos em saúde e demanda do usuário. O sucesso do atendimento domiciliar compartilhado consiste em uma série de habilidades de observação e comunicação por parte dos profissionais que realizam o apoio.
Atendimento Compartilhado	Código 0301050023	O atendimento compartilhado ou consulta compartilhada é uma estratégia na rotina de trabalho de um profissional da equipe multiprofissional.

		As consultas compartilhadas constituem ótima ocasião para um contato pessoal entre eSF de apoio e usuário, oportunizando momento de discussão sobre o caso antes e após atendimento, conforme pactuado no matriciamento ou horário do apoio técnico.
Atividade Coletiva/Grupo Compartilhada e Específica	Código 0301040087	São ações que podem ser de: prevenção, promoção e reabilitação realizadas tanto por equipe multiprofissional e profissionais da equipe de Estratégia Saúde da Família, de forma individual ou compartilhada.
Reunião para Discussão de Casos Clínicos (Matriciamento)	Código 99980056	Clínico-assistencial: Gera uma ação direta aos usuários, seja por meio de visitas domiciliares, consultas compartilhadas e/ou individuais e ações paliativas; Técnico/pedagógica: Gera ações de educação em saúde e qualificação para com a equipe matriciada. Importante registro no sistema de informação vigente.
Prática Corporal / Atividade Física em Grupo	Código 0101010036	As práticas corporais visam a diminuição do sedentarismo e a melhoria da qualidade de vida.

Fonte: Tabela Sigtap, 2023



5 ACESSO A AVALIAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

O profissional de qualquer Unidade de Saúde da Atenção Primária poderá solicitar avaliação da Equipe Multiprofissional do usuário por meio do preenchimento do Formulário Google Institucional, disponibilizado pela Gerência da APS, sendo que em sete dias úteis a Categoria solicitada avaliará a demanda do formulário e sinaliza o desfecho da situação apresentada, podendo ter como devolutiva: matriciamento ou situação excepcional.

5.1 Matriciamento: reunião para discussão de casos clínicos, com o objetivo de aumentar a resolutividade/capacidade de cuidado das equipes de saúde e do escopo das ações na Atenção Primária, tanto para necessidades individuais ou coletivas do usuário, promovendo assim o cuidado compartilhado. O tempo dessa reunião ocorrerá em até 02 horas por equipe de ESF por mês.

Os principais objetivos do matriciamento são:

- ✓ Proporcionar ao usuário, o atendimento Clínico-assistencial por meio da realização de visitas domiciliares, consultas compartilhadas e/ou individuais, e ações paliativas;
- ✓ Realizar ações de educação em saúde para qualificação **técnico/pedagógica** das equipes ESF que estão sob a responsabilidade da EM.

Importante ressaltar que, durante o matriciamento deve-se ter uma organização dos casos pactuados entre os profissionais do EM e eSF, utilizando sempre a ficha de monitoramento no Apêndice C, com o objetivo de registrar as devolutivas e as novas demandas. Essa organização levará em consideração todos os casos que estão em aberto no matriciamento como os discutidos em reuniões anteriores e os que permanecem com pendências. Os casos em que a EM foi acionada no Horário de Apoio Técnico ou em qualquer outro momento oportuno também devem fazer parte desse matriciamento e organização.

5.2 Situações Excepcionais: são as situações que não podem aguardar o matriciamento (Apêndice A), devendo ser avaliadas em menor tempo de espera possível, levando em consideração a condicionante do usuário estar sob o risco de agravamento da situação. Os profissionais da eSF devem dirigir-se à categoria profissional da EM que melhor contemple a situação, no horário de apoio técnico preferencialmente.

Salienta-se que na Situação Excepcional pode ocorrer a inserção de um novo usuário para avaliação, devendo a EM ser acionada diretamente no horário de Apoio Técnico ou quando for necessário, desde que não interrompa os atendimentos em execução.

O Apoio Técnico destina-se à discussão de casos excepcionais identificados pelos profissionais da eSF e que não podem aguardar a data do matriciamento com a Equipe Multiprofissional, reservando-se 01 hora diária na agenda para discussão desta demanda. Os profissionais da Equipe Multiprofissional com carga horária de 06 horas, o seu apoio técnico é de

30 minutos diários.

A Equipe Multiprofissional possui autonomia para realizar encaminhamentos para outras categorias da EM, desde de que os usuários já estejam em atendimento.

6 INSTRUMENTOS DE TRABALHO

6.1 Projeto Terapêutico Singular (PTS)

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é um instrumento de organização do cuidado em saúde construído com a participação do usuário e dos profissionais de saúde pertinentes, quando necessário com os familiares. O PTS levará em consideração as singularidades do sujeito e a complexidade de cada caso (Apêndice B).

A construção do PTS pode ser sistematizada em quatro momentos conforme publicação do MS na Oficina de Qualificação do NASF – Brasil, 2010b.

6.1.1 Diagnóstico Situacional: é o momento em que a equipe realiza um levantamento do usuário, na sua condição de “sujeito singular”, garantindo um olhar de saúde, social, cultural, educacional, laboral, emocional e de rede familiar, compreendendo assim, o sujeito como protagonista e/ou coadjuvante das suas relações. Por meio desse levantamento os profissionais de saúde poderão sintetizar um consenso operacional que auxiliará na identificação da situação a ser trabalhada com o usuário.

6.1.2 Definição de Metas: Uma vez identificado o diagnóstico, constrói-se a-propostas a curto, médio e longo prazo que serão negociadas com o usuário e as pessoas envolvidas. A abordagem deverá ser feita, preferencialmente, pelo membro da equipe que tiver um melhor vínculo com o usuário.

6.1.3 Divisão de Responsabilidades: É importante definir as tarefas de cada um dos envolvidos no PTS, conforme pactuado. O usuário terá um Profissional de Referência, independente da formação, que o auxiliará no andamento das ações acordadas no PTS, como também, caso seja necessário acionar a EM.

6.1.4 Reavaliação: é o momento em que todos os profissionais envolvidos neste PTS do usuário, avaliam e reavaliam as propostas, prazos, impactos e resolutividades na vida do usuário.

6.2 Práticas Integrativas e Complementares em Saúde

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), possui uma perspectiva da prevenção de agravos, da promoção e recuperação da saúde, principalmente na APS, no qual possui como premissa o cuidado continuado, humanizado e integral do usuário. Segundo o Ministério da Saúde, as PICS contribuem para a resolubilidade do Sistema Único de Saúde (SUS), possuindo um potencial para racionalizar as ações em saúde, estimulando alternativas inovadoras

e socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável de comunidades.

Ressalta-se que é uma prática complementar que pode ser exercida por qualquer pessoa qualificada para determinada prática, não sendo exclusividade do profissional da Equipe Multiprofissional.

No entanto, para que sejam realizadas no município de Joinville, o profissional deve seguir as recomendações da Portaria nº 173/2019/SMS publicada em 23/09/2019 no Sistema Eletrônico de Informação (SEI) nº 19.0.130103-3.

6.3 Orientação sobre Grupos

O atendimento em grupo na Atenção Primária à Saúde permite ao profissional a possibilidade de aproximação do usuário que necessita de intervenções por meio de ações educativas, de aprender a conviver com a doença ou situação apresentada num determinado momento. Segundo o Caderno 39 da Atenção Básica, atuar somente na cura, não é capaz de melhorar de forma satisfatória os indicadores de saúde e qualidade de vida das pessoas. (Brasil 2014a).

As atividades coletivas constituem importante recurso no cuidado aos usuários e contribui para a responsabilização do usuário por sua saúde. Existem diferentes modalidades de grupos, tais como: grupos abertos, grupos semiestruturados, grupos fechados (com começo, meio e fim), grupos temáticos relacionados a determinadas patologias, oficinas temáticas, grupos de consumo consciente de medicação, grupos terapêuticos e grupos psicoterapêuticos.

Os grupos terapêuticos são formas importantes de atividades coletivas, enfatizando a prevenção ou o tratamento dos agravos em saúde podendo ser organizados das mais diversas formas como: por faixa etária, agravo em saúde e vulnerabilidade psicossocial, podendo ser homogêneos ou heterogêneos e com frequência e duração estabelecida a partir da avaliação do profissional responsável. Os grupos com o foco na Educação em Saúde propiciam ao usuário o desenvolvimento da sua autonomia, maior participação social, integração, apoio psíquico e trocas de experiências, contribuindo assim, para a resiliência do indivíduo.

6.4 Grupos conduzidos pela Equipe Mínima da ESF

Existem diferentes grupos que podem ser realizados no seu território como:

- ✓ Sobrepeso e Obesidade;
- ✓ Hipertensão (HAS)/Diabetes Mellitus (DM);
- ✓ Autocuidado Apoiado (Grupo Estruturado);
- ✓ Tabagismo (Grupo Semiestruturado);
- ✓ Gestante;
- ✓ Mais Saúde (Grupo Estruturado);

- ✓ Práticas Corporais;
- ✓ Grupos de Convivência;
- ✓ Grupo de Cuidador.

Estes grupos podem ser planejados e conduzidos em parcerias entre as equipes de saúde da mesma Unidade, ou com as Unidades próximas, sendo que o cronograma dessas atividades, quando acordadas, devem ser compartilhados.

Os profissionais da Equipe Multiprofissional podem ser convidados para participar e apoiar em momentos específicos nesses grupos e contribuir de forma ativa na programação estabelecida em conjunto com a Equipe de ESF.

6.5 Grupos conduzidos pela Equipe Multiprofissional

Nos grupos conduzidos pela EM podem ser de modalidades fechadas ou abertas. Os grupos abertos são formados por usuários que tiveram suas demandas identificadas, tanto pela EM como pela eSF, e que podem iniciar a sua participação no grupo a qualquer momento, sendo este um grupo que pode ser permanente. Já os grupos fechados são usuários indicados pela EM, com número específico de participantes, com início e término determinados e a indicação de novos usuários dar-se-á com a formação de um novo grupo.

Alguns exemplos de grupos:

- ✓ Grupos Terapêuticos;
- ✓ Psicoterapêuticos;
- ✓ Grupos de Educação em Saúde com temas relevantes identificados em conjunto com a eSF;
- ✓ Práticas Corporais;
- ✓ Orientação de Pais: sugestão material do Grupo de Parentalidade;
- ✓ Uso adequado de medicações.

Os profissionais da eSF podem ser convidados para participar e apoiar nos referidos grupos em momentos específicos.

Observações:

- ✓ Os grupos poderão ser conduzidos por uma ou mais categorias profissionais, dependendo do objetivo do grupo;
- ✓ Os cronogramas das atividades devem ser compartilhados com equipes de eSF e coordenações.

7 ORGANIZAÇÃO DA AGENDA

A agenda da Equipe Multiprofissional deve contemplar as complexas realidades de cada uma das Equipes vinculadas, possibilitando ações que podem ser realizadas no trabalho integrado entre os profissionais.

A Deliberação CIB 263/2021/SC (p.02) descreve a agenda e suas respectivas práticas do cotidiano como:

Atividades de contato direto com usuário, planejamento documental e contato com demais profissionais, equipes de saúde, assistência social, educação, habitação, etc. ... flexível com pelo menos 60% do tempo dedicado ao atendimento direto dos usuários da APS, Adoção de atividades coletivas custo-efetivas e com abrangência territorial relevante, com começo, meio e fim, planejamento das atividades com base nas necessidades das equipes de APS apoiadas, priorização dos usuários com maiores vulnerabilidades e carga de morbidade/adoecimento no acesso e seguimento clínico.

A agenda deve contemplar atendimento individual, em grupo, domiciliar, educação em saúde, matriciamento, apoio técnico, reunião de Equipe, entre outras atividades necessárias.

Importante:

- ✓ Sempre que os profissionais da EM forem demandados pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Sistema de Justiça (NAT-Jus), estes deverão ter tempo hábil (pelo menos 5 dias úteis), a partir da data da ciência do profissional, em conformidade com a disponibilidade da agenda, para ler todo o processo e confeccionar o relatório solicitado, bem como terem as decisões técnicas respeitadas;
- ✓ As atividades em grupos serão conduzidas por um profissional da EM, só terá a presença de mais de um profissional se for necessário, pois é importante otimizar a oferta dos serviços prestados aos usuários;
- ✓ Os horários de Apoio Técnico devem estar previstos na agenda dos profissionais. Quando a coordenação verificar que estes horários não estão sendo utilizados para a finalidade prevista, poderá ser utilizado de maneira mais adequada para a realidade local;
- ✓ Também deve estar previsto na agenda, horário semanal para avaliação das solicitações enviadas das eSF pela plataforma *google forms* para EM.



8 INSTRUMENTOS DE APOIO

- ✓ Grupo de Tabagismo (material deve ser solicitado no CAME e folder pode ser acessado no SEI 18.0.013493-0);
- ✓ Grupo de Parentalidade: 04 Encontros Estruturados para Orientação para Pais e/ou responsáveis de crianças de 00 a 03 anos, elaborado por profissionais do Grupo Condutor da Raps:
<https://drive.google.com/drive/folders/1aVh5SxECJN_k532z753Zhc_OvYYdR3TU?usp=sharing>;
- ✓ Instrumento para o Auto Cuidado Apoiado (Apêndice D);
- ✓ Sugestões temas do Grupo Mais Saúde (Apêndice E);
- ✓ Indicadores do PMAQ: Nasf <<https://aps.saude.gov.br/noticia/2473>>.



REFERÊNCIAS

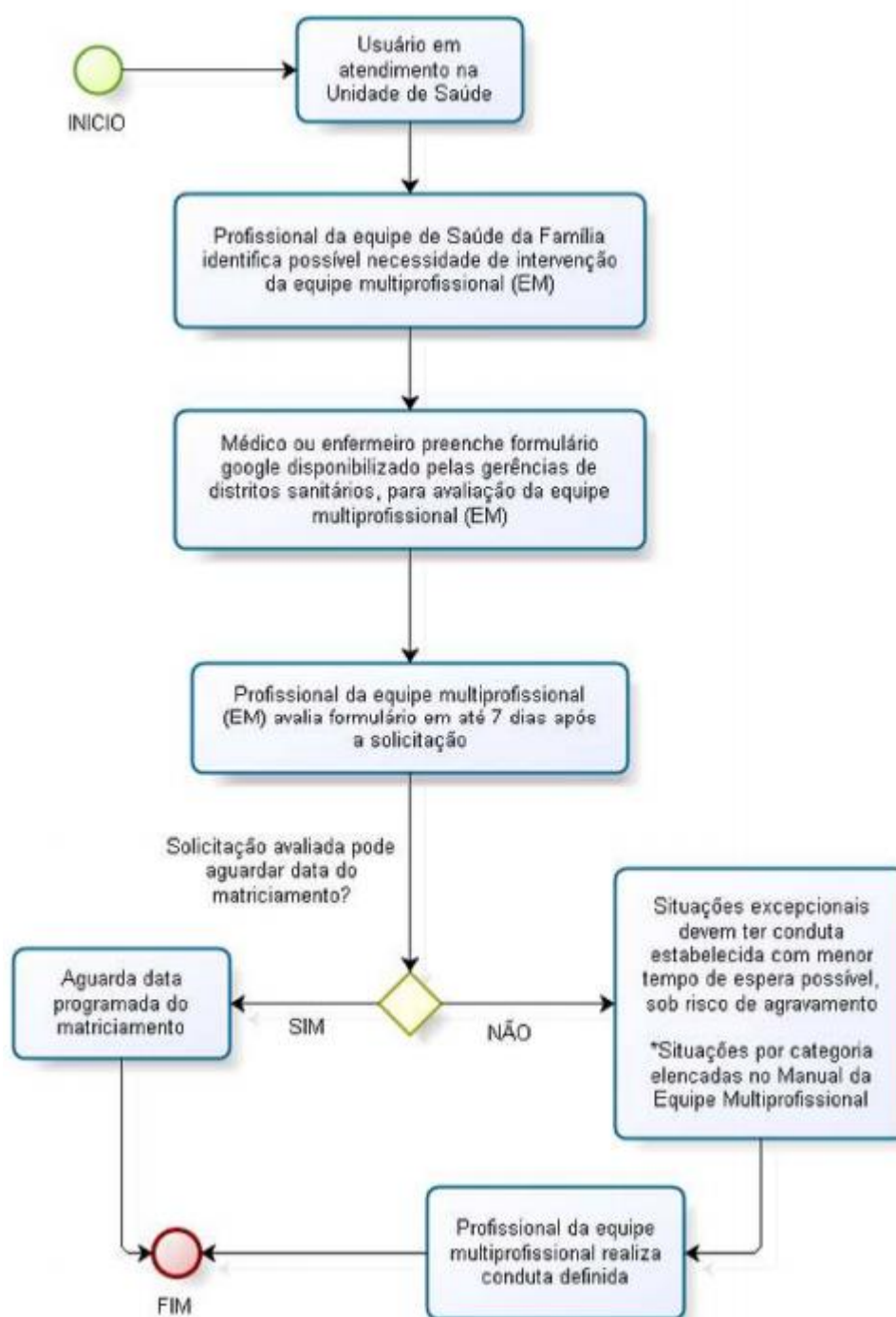
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS). Departamento de Saúde da Família. **Nota Técnica nº 3/2020-DESF/SAPS/MS**. Brasília – DF: 2020.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Práticas Farmacêuticas no Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf AB)** [recurso eletrônico]. Brasília – DF: 2018.
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS). **Indicadores do PMAQ: NASF**. Brasília – DF: 2017. Disponível em: <<https://aps.saude.gov.br/noticia/2473>>. Acesso em 11/02/2022.
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Núcleo de Apoio à Saúde da Família. **Cadernos de Atenção Básica, nº 39**. Brasília – DF: 2014a.
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de Apoio à Gestão Participativa. **II Caderno de educação popular em saúde**. Brasília – DF: 2014b.
6. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Diretrizes do Nasf: Núcleo de Apoio à Saúde da Família**. Caderno de Atenção Básica, nº 27. Brasília – DF: 2010a.
7. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Oficina de qualificação do Nasf**. Brasília – DF: 2010b.
8. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de Apoio à Gestão Participativa. **Caderno de educação popular e saúde**. Brasília – DF: 2007.
9. BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 8.662, de 07 de junho de 1993**. Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providências. Brasília – DF: 2012.
10. CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (Coffito). **Definição da ciência da Terapia Ocupacional**. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?page_id=3382>. Acesso em 01/02/2023.
11. CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CFP). **Resolução nº 17, de 19 de julho de 2022**. Dispõe acerca de parâmetros para práticas psicológicas em contextos de Atenção Básica, secundária e terciária de saúde. Brasília – DF: 2022.
12. CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CFP). Conselhos Regionais de Psicologia e Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas. **Referências técnicas**



- para atuação de psicólogas (os) na Atenção Básica à Saúde.** 2ª edição. Brasília – DF: 2019.
13. CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. **Código de Ética do/a Assistente Social.** Lei nº 8.662, de 07 de junho de 1993, de regulamentação da profissão. 10ª ed. rev. e atual. Brasília – DF: 2012.
 14. CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. **Parâmetros para a atuação de assistentes sociais na Política de Saúde.** Série Trabalho e Projeto Profissional nas Políticas Sociais. Brasília – DF: 2015.
 15. CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA DÉCIMA REGIÃO (Crefito 10). **Definição da ciência da Fisioterapia.** Disponível em: <<https://crefite10.org.br/portal/index.php/fisioterapia-definicao/>>. Acesso em 01/02/2023.
 16. COTTA, R.M.M, *et al.* **Organização do trabalho e perfil dos profissionais do programa Saúde da Família:** um desafio na reestruturação da Atenção Básica em Saúde. Epidemiologia e Serviços de Saúde. Brasília – DF: 2006. v. 15, n.4, p. 7-18, out/dez. 2006.
 17. IAMAMOTO, Marilda Vilela. **O Serviço Social na contemporaneidade:** dimensões históricas, teóricas e ético-políticas. Fortaleza, CRESS-CE, Debate n.6, 1997.
 18. PREFEITURA DE CURITIBA. Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba. **Autocuidado apoiado:** caderno de exercícios. Curitiba – PR: 2012.
 19. PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria da Saúde de Joinville. **Decreto nº 30.043, de 14 de novembro de 2017.** Institui o Núcleo de Apoio Técnico ao Sistema de Justiça - NAT-Jus, regulamenta os procedimentos voltados à prevenção e resolução administrativa de litígios na saúde e dá outras providências. Joinville – SC: 2017. Disponível em: Processo SEI 17.0.064964-4.
 20. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC). Núcleo Telessaúde Santa Catarina. Ministério da Saúde. **Trabalhando com grupos na Atenção Básica** [recurso eletrônico]. Aimée Bianchessi Sauer, *et al.* Dados Eletrônicos. Florianópolis – DF: 2018.

APÊNDICE A – Fluxograma de acesso à avaliação com a Equipe Multiprofissional

Figura 01: Fluxograma de acesso à avaliação com a Equipe Multiprofissional



Fonte: SES/Joinville, 2023

APÊNDICE B – Projeto Terapêutico Singular (PTS)

Equipe Multiprofissional Projeto Terapêutico Singular (PTS)	Página 01 de 02
--	------------------------

Usuário: _____ DN: ____/____/____

UBSF: _____ eSF: _____

Data do Matriciamento: ____/____/____

Acompanhamento: () Em andamento () Finalizado

1 - Diagnóstico:

Queixa/situação/demanda:

Contexto familiar e social:

Informações e ações clínicas já realizadas:

Percepções dos profissionais de saúde:

Percepções do usuário/família:

Análise de resiliência, potencialidades e vulnerabilidades:



2 - Definição

Metas	Ação	Responsável*	Prazo**

*Usuário, eSF e ou EM

****Curto, médio e longo prazo**

É importante a participação do usuário na sua definição.

3 - Gestão do PTS:

Importante: A definição do profissional com a função de gestão do PTS (aquele com melhor vínculo com o usuário).

Função: Lembrar, acompanhar e articular ações para favorecer a dinâmica de continuidade no processo de cuidado.

4 - Reavaliação

Discussão da evolução do caso e reavaliação de conduta, caso seja necessário.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

APENDICE C – Lista de monitoramento de solicitação de Apoio Matricial

[illegible]